# Mésothéliome pleural malin

chez un ancien calorifugeur exposé à l'amiante — cas clinique évolutif

Présenté par **BABAAISSA Zakaria** · Encadrement : **Dr. S. Labouabi** · Module de médecine du travail · 6ème année · Faculté de médecine de Laghouat · 2026/2027

**Résumé du cours**

## 1. Définition

Tumeur **maligne primitive**, très agressive, née des **cellules mésothéliales** qui tapissent la plèvre (≈ 90 %), plus rarement le péritoine ou le péricarde.

## 2. Étiologie et latence

- **Amiante** : facteur majeur et avéré (> 80 % des cas) ; amphiboles plus agressives que le chrysotile.
- **Tabac** : pas un facteur inducteur du mésothéliome (≠ cancer bronchopulmonaire).
- **Latence** : 20 à 50 ans après la 1re exposition.

## 3. Secteurs à risque en Algérie

Fibrociment (plaques, conduites) · Bâtiment (rénovation, démolition) · Mécanique automobile (freins, embrayages) · Chantiers navals (isolation thermique, calorifugeage, chaudronnerie).

## 4. Physiopathologie

Inhalation de fibres → migration vers la plèvre → irritation mécanique, stress oxydatif, inflammation chronique → lésions de l'ADN → transformation maligne des cellules mésothéliales.

## 5. Plaques pleurales ou mésothéliome ?

- **Plaques** : fibrose localisée ± calcifiée de la plèvre pariétale, **bénigne**, asymptomatique, marqueur d'exposition.
- **Mésothéliome** : **malin**, épaississement nodulaire, irrégulier, circonférentiel (> 1 cm), plèvre « en cuirasse », poumon englobé et rétracté.

## 6. Imagerie

- **Radiographie** : épaississement pleural lobulé, opacité/épanchement unilatéral, rétraction de l'hémithorax.
- **TDM** : épaississement circonférentiel nodulaire > 1 cm, atteinte de la plèvre médiastinale, épanchement ; oriente sans prouver.

## 7. Clinique (et pourquoi)

- **Dyspnée** : épanchement et plèvre rigide compriment le poumon.
- **Douleur thoracique** : invasion de la paroi, de la plèvre pariétale, du diaphragme.
- **AEG** : syndrome inflammatoire tumoral.

Signes peu spécifiques : c'est le contexte d'exposition qui oriente.

## 8. Diagnostic de certitude

Cytologie souvent négative → **biopsies pleurales sous thoracoscopie → histologie + immunohistochimie**. Formes : épithélioïde (60–80 %, meilleur pronostic), biphasique, sarcomatoïde (très agressive).

## 9. Prise en charge

RCP · chimiothérapie cisplatine + pémétrexed · immunothérapie (double blocage) · chirurgie/radiothérapie au cas par cas · soins de support (pleurodèse au talc, douleur).

## 10. Cadre médico-légal en Algérie

Tableau n° 30 (CNAS) : asbestose, lésions pleurales bénignes, **mésothéliome malin primitif (DPC 30 ans)**, autres tumeurs pleurales primitives, cancers bronchopulmonaires. Liste des travaux **indicative** (dont le calorifugeage).

DPC = délai **maximal** entre fin d'exposition et 1re constatation médicale.

## 11. Asbestose ou mésothéliome ?

| | Asbestose | Mésothéliome |
|---|---|---|
| Nature | Fibrose, non cancéreuse | Cancer très agressif |
| Siège | Parenchyme | Plèvre (membrane) |
| Évolution | Chronique ; ↑ risque de cancer du poumon | Pronostic très sombre |

## Cas clinique

B. Abdelkader, homme de 67 ans · ancien calorifugeur, retraité Motif de consultation · Dyspnée progressivement croissante depuis 3 mois · Douleur thoracique gauche · Amaigrissement de 6 kg · Antécédents · HTA traitée · Tabagisme : 12 paquets-années, sevré depuis 18 ans · Examen clinique · FR 23/min · $SpO_2$ 93 % (air ambiant) · Diminution du murmure vésiculaire à la base gauche · Matité à la base gauche ·

**QCM 1 — Diagnostics à évoquer**

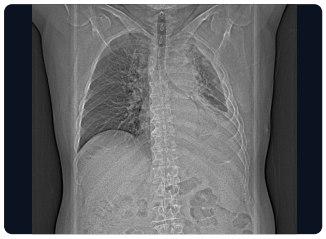
Homme de 67 ans, **ancien calorifugeur**, ex-fumeur : **dyspnée** progressive, **douleur thoracique gauche**, **amaigrissement de 6 kg** et **syndrome d'épanchement pleural gauche**.

**Devant ce tableau clinique, quels sont les diagnostics à évoquer ?**

A. Cancer bronchopulmonaire
B. Mésothéliome pleural malin
C. Pleurésie métastatique d'un autre cancer primitif
D. Tuberculose pleurale (pleurésie tuberculeuse)
E. Une insuffisance cardiaque gauche
F. Asbestose

**QCM 2 — Présentation clinique**

Une **radiographie thoracique** a été réalisée.

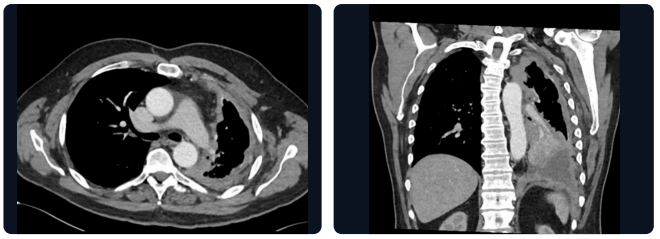


**Concernant la présentation clinique, quelles propositions sont exactes ?**

A. Une latence de plus de vingt ans après la dernière exposition à l'amiante rend moins probable un mésothéliome lié au travail, comparativement à une tumeur survenant dans les dix premières années.
B. Une radiographie thoracique montrant un épanchement pleural unilatéral permet de différencier un mésothéliome d'une métastase pleurale.
C. La découverte d'un épanchement pleural chez un ancien calorifugeur justifie une enquête d'exposition même si le patient ne rapporte spontanément aucun contact avec l'amiante.
D. Chez un patient ayant fumé et travaillé au contact d'isolants anciens, la quantification du tabagisme permet de hiérarchiser les deux expositions dans l'attribution causale du mésothéliome.
E. L'absence de plaques pleurales ou de signes radiologiques d'asbestose rend peu probable l'imputabilité d'un mésothéliome à une exposition professionnelle à l'amiante.

**QCM 3 — Imagerie : scanner thoracique**

Un **scanner thoracique** a été réalisé. Faites défiler les coupes pour l'analyser.



**Concernant le scanner thoracique, quelles propositions sont exactes ?**

A. Dans ce cas, la TDM est faite sans injection.
B. L'association d'un épaississement pleural nodulaire circonférentiel et d'une réduction du volume de l'hémithorax est évocatrice d'un mésothéliome pleural malin, sans être spécifique.
C. L'effacement des plans graisseux entre l'épaississement pleural et l'aorte thoracique ou le péricarde fait suspecter une extension locale, sans démontrer à lui seul une invasion histologique de ces structures.
D. Une TDM très évocatrice associée à une exposition ancienne à l'amiante permet de retenir définitivement le diagnostic.

**QCM 4 — Cytologie pleurale**

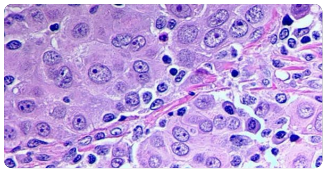
La ponction pleurale retrouve un **exsudat séro-hématique**. La cytologie est **négative**.

**Devant cet épanchement séro-hématique exsudatif avec une cytologie négative, que peut-on dire de la rentabilité de la cytologie dans le mésothéliome pleural ?**

A. La cytologie est toujours positive dans le type épithélioïde, ce qui élimine le diagnostic.
B. La cytologie du liquide pleural a une faible sensibilité (< 30–50 %) dans le mésothéliome, rendant la biopsie indispensable.
C. Les cellules mésothéliales malignes ressemblent fortement à des cellules mésothéliales réactionnelles.
D. La cytologie négative prouve qu'il s'agit d'une pathologie bénigne liée à l'amiante (plaques pleurales).
E. La cytologie du liquide pleural est considérée comme insuffisante pour exclure ou affirmer un mésothéliome pleural.

### QCM 5 — Biopsie et anatomopathologie

Une **biopsie pleurale thoracoscopique** confirme un **mésothéliome malin pleural de type épithélioïde**.



**Concernant la biopsie et l'examen anatomopathologique, quelles propositions sont exactes ?**

A. La biopsie pour mésothéliome est réalisée à l'aveugle à l'aiguille de trocart.

B. Les prélèvements cytologiques (liquide pleural) seuls sont insuffisants pour affirmer le diagnostic.

C. Le mésothéliome épithélioïde est le type le plus fréquent (50 à 80 % des cas) ; il présente le pronostic le plus favorable.

D. Une prolifération tumorale à différenciation épithélioïde à l'histologie permet de distinguer un mésothéliome épithélioïde d'un adénocarcinome pulmonaire lorsque le prélèvement est suffisamment représentatif.

E. L'examen anatomopathologique est indispensable et obligatoire pour la reconnaissance en maladie professionnelle d'un mésothéliome.

### QCM 6 — Enquête professionnelle — tableau

**Enquête professionnelle et situation médico-légale**

Le patient a exercé comme **calorifugeur de 1978 à 2003** dans plusieurs entreprises de maintenance industrielle. Ses tâches comprenaient la **découpe, la pose et le retrait d'anciens isolants thermiques**. Il rapporte des travaux poussiéreux, parfois en espace confiné, une ventilation insuffisante et une utilisation irrégulière des protections respiratoires.

Les archives professionnelles sont **incomplètes**. Deux anciens collègues confirment des conditions de travail similaires. Aucune mesure individuelle historique de concentration en fibres n'est disponible.



**Quels raisonnements sont appropriés dans le cadre réglementaire algérien ?**

A. Le tableau n° 31 relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante est celui à examiner pour le mésothéliome pleural.

B. La liste des travaux du tableau est indicative et les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée d'exposition doivent être respectées.

C. Le délai de prise en charge de 30 ans correspond à la durée minimale d'exposition professionnelle à l'amiante devant être démontrée pour permettre la reconnaissance.

D. La désignation de la maladie et le respect du délai de prise en charge ne dispensent pas de vérifier les autres conditions du tableau, notamment celles relatives aux travaux susceptibles de provoquer l'affection.

E. L'absence de mesures individuelles historiques de concentration en fibres n'exclut pas la reconnaissance de la maladie professionnelle.

### QCM 7 — Chronologie et délais

**Chronologie**

- **1978** Première exposition suspectée
- **2003** Dernière exposition suspectée
- **Juin 2026** Début des symptômes
- **18 sept. 2026 Première constatation médicale documentée**
- **2 oct. 2026** Confirmation histologique

**Situation actuelle :** diagnostic confirmé, origine professionnelle suspectée, reconnaissance par la CNAS non encore prononcée.

**Concernant les dates du dossier, quelles propositions sont exactes ?**

A. Si les premiers symptômes remontent à juin 2026, le délai réglementaire doit obligatoirement être calculé à partir de cette date, même si aucune constatation médicale n'a alors été réalisée.

B. Le délai de prise en charge prévu par un tableau professionnel se calcule en tenant compte de la période réglementaire définie après la cessation de l'exposition.

C. Une date de cessation d'exposition établie en 2003 et une première constatation médicale retenue en septembre 2026 correspondent à un intervalle d'environ 23 ans ; cet intervalle est inférieur à 30 ans, donc le délai de prise en charge n'est pas respecté.

D. Les dates de cessation d'exposition, de première constatation médicale et de diagnostic doivent être documentées avec précision.

E. Aucune durée minimale d'exposition n'est légalement exigée dans le tableau pour le mésothéliome.

### QCM 8 — Certificat médical

Un **certificat de maladie professionnelle** a été établi.



وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
Accidents du Travail et Maladies Professionnelles

CERTIFICAT MÉDICAL
INITIAL OU DE PROLONGATION

☑ MALADIE PROFESSIONNELLE
☐ MALADIE À CARACTÈRE PROFESSIONNEL

Je soussigné, Docteur : BABAISSA Zakaria
Grade et spécialité : Médecin spécialiste en Médecine du Travail
Adresse professionnelle : Service de Médecine du Travail, Établissement Hospitalier Universitaire de Laghouat
Certifie avoir examiné M. : B. Abdelkader
Date de naissance : 07 / 10 / 1975 à : Laghouat
Employé(e) actuellement par : Sans emploi depuis 2003 (ancien salarié)
En qualité de : Ancien calorifugeur au poste de : Travaux d'isolation thermique et de calorifugeage
Nature du travail effectué au moment de l'exposition au risque : Manipulation et retrait d'isolants susceptibles de contenir de l'amiante, avec exposition professionnelle aux poussières d'amiante.
Constate et certifie ce qui suit (1) :
Mésothéliome pleural malin primitif confirmé par examen anatomopathologique, dans un contexte d'exposition professionnelle ancienne à l'amiante.
Son état nécessite un arrêt de travail de : [ ] jours,
à compter du : [ ] / [ ] / [ ]
et présente une incapacité permanente de : [ ] %.
Fait à : Laghouat le 25/10/2026
Cachet et Signature du Médecin
Dr BABAISSA Zakaria
Médecin spécialiste en Médecine du Travail
Service de Médecine du Travail

(1) Mettre une croix dans la case correspondante.
(2) Fournir toutes indications utiles sur la maladie et ses symptômes. Indiquer si possible la durée de la maladie et éventuellement spécifier si elle doit entraîner une incapacité de travail.

**Un certificat de maladie professionnelle a été établi. Cochez les réponses justes :**

A. C'est un certificat de constatation de la maladie établi en deux exemplaires.

B. C'est un certificat médical initial (CMI) de maladie à caractère professionnel.

C. Il contient l'identité du patient, les coordonnées du médecin, la description détaillée de l'affection ainsi que la durée éventuelle de l'arrêt de travail.

D. Il sert à décrire précisément l'état de santé du patient et la date de la première constatation médicale, servant de base obligatoire pour l'examen du dossier par le médecin-conseil.

E. Il peut être rédigé par le médecin traitant, un médecin spécialiste, un praticien hospitalier ou le médecin du travail.

### QCM 9 — Preuve de l'exposition

L'exposition professionnelle paraît plausible, mais certaines **archives sont manquantes**.

**Quelles propositions sont exactes ?**

A. Si le patient a déjà passé des scanners thoraciques montrant des plaques pleurales calcifiées, ces dernières constituent une « signature » radiologique incontestable d'une exposition passée à l'amiante.

B. Les témoignages de collègues peuvent compléter l'enquête, sans dispenser de l'examen des autres éléments disponibles.

C. Il n'est pas obligatoire de prouver scientifiquement la présence de fibres. Il faut prouver l'exercice de la profession et la nature des tâches.

D. L'existence d'une exposition extraprofessionnelle exclut une origine professionnelle.

### QCM 10 — Prévention

L'enquête révèle que **d'autres travailleurs** ont effectué des travaux comparables sur les mêmes installations.

**Quelles propositions sont exactes ?**

A. Le port d'un appareil de protection respiratoire adapté et la surveillance médicale périodique constituent les principales mesures de prévention primaire, puisqu'ils permettent d'éviter l'apparition de la maladie.

B. La traçabilité de l'exposition professionnelle et la surveillance médicale des travailleurs exposés s'inscrivent dans une démarche de prévention secondaire.

C. Le reclassement professionnel d'un travailleur atteint d'un mésothéliome pleural malin constitue une mesure de prévention secondaire visant à dépister précocement les complications.

D. La déclaration de la maladie professionnelle, l'accompagnement médico-social et l'indemnisation d'un travailleur atteint relèvent principalement de la prévention tertiaire.

E. L'interdiction de l'importation et de la commercialisation de toutes les variétés de fibres d'amiante a été finalisée par le décret exécutif n° 09-321 en octobre 2009.

---

**Les réponses :**

**1.** A+B+C+D **2.** C **3.** B+C **4.** B+C+E **5.** B+C+E **6.** B+D+E **7.** B+D+E **8.** C+D+E **9.** A+B+C **10.** B+D+E

Images de scanner : Radiopaedia.org · Illustrations de la plèvre : M. Skalski (CC BY-NC-ND)